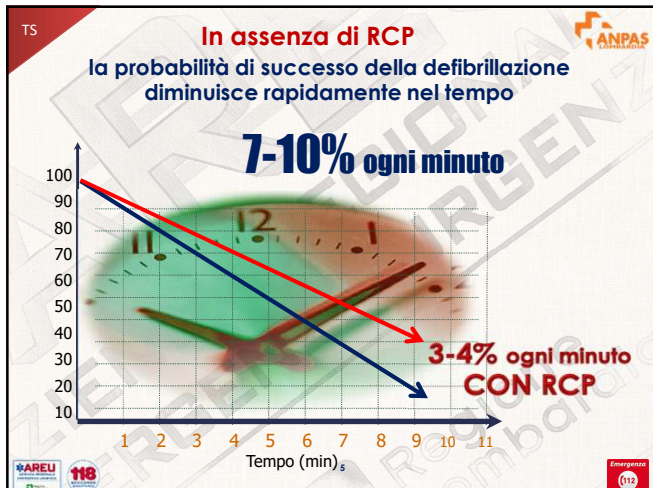














TS

ANPAS

La catena della sopravvivenza



**Immediato riconoscimento dell'ACC
e attivazione del Sistema di risposta
delle emergenze**

- Il pronto riconoscimento dei segni clinici è uno dei fattori chiave della catena della sopravvivenza.
- Allertare tempestivamente il soccorso sanitario (118/112) e seguire le indicazioni fornite dall'operatore





TS

ANPAS

La catena della sopravvivenza



**RCP precoce
COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE**

- La Rianimazione Cardio-Polmonare (in particolare le CTE) è più efficace se praticata immediatamente dopo l'insorgenza dell'ACC.
- La RCP precoce aumenta le probabilità che lo shock elettrico della defibrillazione riesca ad interrompere la FV/TV.





TS

ANPAS

La catena della sopravvivenza



Defibrillazione rapida

- Consiste nel far attraversare il cuore da una adeguata scarica di corrente elettrica, con lo scopo di azzerare il caos elettrico cardiaco e interrompere la FV/TV
- La RCP precoce associata ad una rapida defibrillazione elettrica entro pochi minuti dal collasso può determinare un'elevata percentuale di sopravvivenza





TS

ANPAS

La catena della sopravvivenza


Supporto vitale avanzato efficace

- Manovre di trattamento avanzato messe in atto da personale sanitario (intubazione orotracheale, impiego di farmaci, ecc.) che completano la rianimazione cardiopolmonare con lo scopo di ripristinare le funzioni vitali





TS

ANPAS

La catena della sopravvivenza


Assistenza post-arresto cardiaco adeguata

- Al ripristino del circolo spontaneo sufficiente a mantenere i segni vitali, il proseguimento delle cure prevede l'applicazione di terapie specifiche (ipotermia, angioplastica, ecc.) con lo scopo di restituire alla vittima lo stato neurologico precedente all'ACC.





TS

ANPAS

SEMPRE

VALUTAZIONE



AZIONE







TS

Valuta
SICUREZZA della SCENA

ANPAS

PRIMA DI INTERVENIRE
ACCERTARSI CHE NON VI
SIANO PERICOLI
PER IL SOCCORRITORE
E PER LA VITTIMA

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Valutazione
COSCIENZA e RESPIRO

ANPAS

SIGNORE?...TUTTO
BENE? ...MI SENTI?

RISPONDE

**RESPIRA
NORMALMENTE**

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Valutazione
RESPIRO

ANPAS

**CONTEMPORANEAMENTE alla
valutazione dello stato di
COSCIENZA**

**OSSERVA RAPIDAMENTE se il
TORACE si solleva**

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Valutazione
RESPIRO

Respiro NORMALE

MOVIMENTI del
TORACE REGOLARI
RITMICI che
AVVENGONO per
circa
12-20 volte al
minuto

Respiro ASSENTE

ASSENZA di
QUALSIASI
MOVIMENTO del
TORACE

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Se la vittima è INCOSCIENTE
con respiro NORMALE

112

Allerta il NUE 112

Posiziona la vittima su
un fianco (PLS)

Controlla
continuamente la
presenza del respiro

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Valutazione
RESPIRO

Respiro ANORMALE
non compatibile con ACC

FREQUENZA
RESPIRATORIA da
NORMALE a ELEVATA
(>10 volte/minuto)
FREQUENTEMENTE
ASSOCIATO a SIBILI,
FISCHI, RANTOLI *

Respiro ANORMALE
compatibile ACC

GASPING; LENTO
(pochi atti respiratori al
minuto), RUSSANTE,
SIMILE AL
SINGHIOZZO,
NON EFFICACE

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Video

RESPIRO anormale (ACC)

ANPAS

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Sequenza **BLSD**

Se la vittima è INCOSCIENTE

con respiro **ANORMALE** o **ASSENTE**

Allerta il N° 112

Chiedi il Defibrillatore (DAE)

Posiziona la vittima SUPINA su PIANO RIGIDO

WAREL

118

Emergenza 112

TS

Sequenza **BLSD**

.....E INIZIA IMMEDIATAMENTE

COMPRESSIONI

TORACICHE ESTERNE

WAREL

118

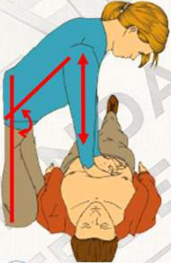
Emergenza 112

TS

Sequenza BLS-D

Compressioni Toraciche Esterne

POSIZIONE del SOCCORRITORE



- Braccia perpendicolari al torace del paziente
- Non piegare i gomiti
- Il fulcro del movimento è il bacino
- Utilizza il peso del tuo corpo come forza di compressione

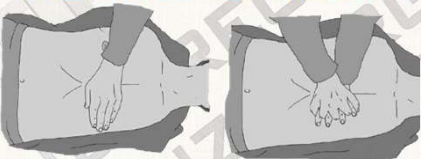
WAREL 118 Emergenza 112

TS

Sequenza BLS-D

Compressioni Toraciche Esterne

POSIZIONE CORRETTA delle MANI



Posiziona la mano al **centro del torace** sulla metà inferiore dello sterno

Appoggia sopra l'altra mano

Intreccia le dita

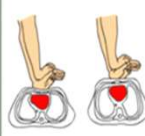
WAREL 118 Emergenza 112

TS

Sequenza BLS-D

Compressioni Toraciche Esterne

- **COMPRI IL TORACE** per una **PROFONDITÀ** di **ALMENO 5 cm** (**NON più di 6 cm**)
- Consenti la **RIESPANSIONE** toracica **COMPLETA** dopo ogni compressione
- **FREQUENZA COMPRESIONI:** da **100/minuto** a **120/minuto** (*almeno 100/minuto*)
- **NON OSTACOLARE LA RIESPANSIONE TORACICA***
- Mantieni il **TEMPO** di **COMPRESIONE** **UGUALE** al **TEMPO** di **RILASCIAMENTO**



WAREL 118 Emergenza 112

TS

Sequenza **BLSD**

Compressioni Toraciche Esterne

INIZIA A COMPRIMERE PER 30 VOLTE



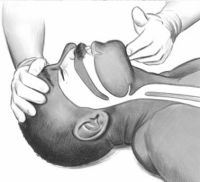
RIDUCI AL MINIMO LA FREQUENZA E LA DURATA DELLE INTERRUZIONI PER AVERE CTE EFFICACI

WAREL 118 Emergenza 112

TS

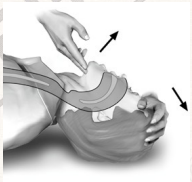
Sequenza **BLSD**

APERTURA DELLE VIE AEREE



ESTENSIONE del CAPO

SOLLEVAMENTO del MENTO



APERTURA DELLA BOCCA

ISPEZIONE VISIVA del CAVO

WAREL 118 Emergenza 112

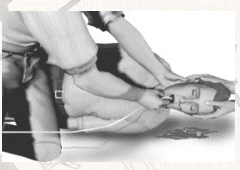
TS

Gestione delle vie aeree **ANPAS**

SVUOTAMENTO CAVO ORALE

SOLO SE SONO EVIDENTI CORPI ESTRANEI SOLIDI O IN CASO DI STORIA DI SOSPETTO CORPO ESTRANEO

RIMOZIONE DI LIQUIDI CONSIDERARE L'ASPIRATORE

WAREL 118 Emergenza 112

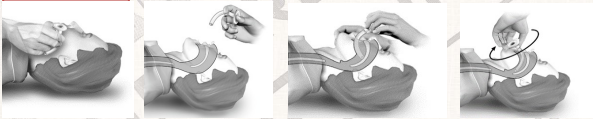
TS

Gestione delle vie aeree

CANNULA ORO-FARINGEA

Posizionare solo in caso di ventilazione difficile o di pervietà delle vie aeree

Misura corretta




NON RITARDARE RCP

WAREL 118 Emergenza 112

TS

Sequenza BLS

esegui 2 ventilazioni

Insuffla un volume sufficiente a sollevare il torace (500/600 ml)

DURATA: 1 secondo ognuna

Lascia espirare

Controlla l'efficacia (ESPANSIONE TORACICA)

WAREL 118 Emergenza 112

TS

Ventilazioni

EVITA di INSUFFLARE VOLUMI ECCESSIVI

Un volume eccessivo comporta:

- Riempimento di aria nello stomaco (con rischio di rigurgito, vomito e inalazione)
- Aumento della pressione intratoracica (con riduzione della perfusione cardiaca)

WAREL 118 Emergenza 112

TS

Ventilazione

PRESIDI

**BOCCA-MASCHERA
(POCKET-MASK)**

BOCCA-BOCCA

Durante la ventilazione

CONTROLLA L'EFFICACIA (ESPANSIONE TORACICA)

TS

Ventilazione

PRESIDI






Supporto alla ventilazione con Poche- Mask

Durante la ventilazione

CONTROLLA L'EFFICACIA (ESPANSIONE TORACICA)






TS

Ventilazione

PRESIDI

Ventilazioni con pallone AMBU autoespandibile se presenti 2 soccorritori

O₂ 12-15 lt/min



Durante la ventilazione

CONTROLLA L'EFFICACIA (ESPANSIONE TORACICA)





118

Emergenza
112

TS

Ventilazione

PRESIDI

**OSSIGENO SEMPRE
10-12 litri/min.**



CON RESERVOIR

O2 aria ambiente: 21% O2 senza reservoir 60%
con Reservoir: 90%

WAREL 118 Emergenza 112

TS

Sequenza BLS

1 SOCCORRITORE

CICLO:

30 COMPRESSIONI TORACICHE

2 VENTILAZIONI

**Rapporto
CTE / Ventilazioni**

30 : 2




WAREL 118 Emergenza 112

TS

Sequenza BLS

2 SOCCORRITORI

**Rapporto
CTE / Ventilazioni**

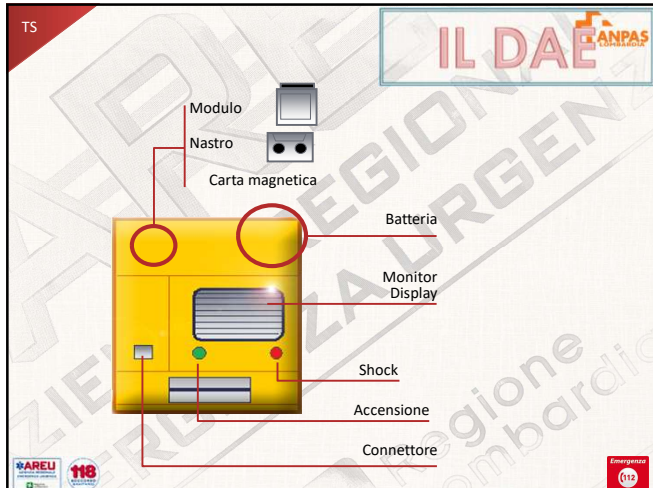
30 : 2




**OGNI 6/7 CICLI (CIRCA 2 MINUTI)
CAMBIO OPERATORE CTE**

(DOPO 2 MINUTI, A CAUSA DELLO SFORZO FISICO, LE CTE PERDONO EFFICACIA)

WAREL 118 Emergenza 112







TS

USO DEL DAE

Posizione degli elettrodi

ANTERO-LATERALE

Sternale: sotto la clavicola destra, a lato dello sterno

Apicale: centro della piastra sulla linea ascellare media all'altezza del 5° spazio intercostale

Applica le piastre

DURANTE L'APPLICAZIONE DELLE PLACCHE RIDURRE AL MINIMO LE INTERRUZIONI DELLE CTE

ANPAS

WAREU

118

Emergency 112

TS

USO DEL DAE

SICUREZZA

Durante le fasi di **ANALISI, CARICA e SCARICA**

NESSUNO

deve essere a contatto con il paziente, con i cavi e le placche del DAE

Consenti l'ANALISI del ritmo

ANPAS

WAREU

118

Emergency 112

TS

USO DEL DAE

SICUREZZA

DURANTE L'ANALISI e PRIMA dell'EROGAZIONE dello SHOCK

Enuncia la filastrocca di sicurezza

IO SONO VIA

VOI SIETE VIA

TUTTI SONO VIA

Durante l'utilizzo, GUARDA SEMPRE IL PAZIENTE E NON IL DAE

CONTROLLO VISIVO

ANPAS

WAREU

118

Emergency 112



USO DEL DAE

SICUREZZA





Prima dell'erogazione
dello shock ALLONTANA
qualsiasi FONTE di
Ossigeno



Dopo lo shock....**RIPRENDI**
IMMEDIATAMENTE LE CTE







TS

Controllo del DAE



Defibrillatori automatici: Checklist dell'operatore di turno

Data: _____ Turno: _____ Sala: _____

Modello: _____ Marca e categoria: _____

☐ Verifica di gestione, dispositivi disponibili, batterie in full capacity, stato dei materiali. Anche se i controlli sono stati eseguiti, il Defibrillatore

		OK	Altrimenti controllare in sede
1	Defibrillatore		
☐	Full, nessuna macchina, nessun oggetto estraneo sopra, pulito e controllato	☐	☐
☐	Cavi, Connessioni		
☐	Ricaricatore plug, con cavi, o danneggiato	☐	☐
☐	Connessioni a parete non sicure o non autorizzate/oggetti	☐	☐
☐	Interni		
☐	Con soli indicatori, confermi visibili, con luce di segnale?	☐	☐
☐	Assegnato:	☐	☐
☐	Funziona:	☐	☐
☐	Display	☐	☐
☐	Indicatore di carica batteria, carica o no?	☐	☐
☐	Indicatore di carica plug, o segnalatore, modello o numero, da quale categoria viene?	☐	☐
☐	Procedura di lavoro		
☐	Apparecchio in funzione	☐	☐
☐	Verificare l'eventuale presenza di ostacoli che impediscono la messa a terra	☐	☐
☐	Disponibilità di personale che si occupa di manovre	☐	☐
☐	Stato e controllo batterie e sistema delle batterie come da manuale	☐	☐
☐	Apparecchio in corretto stato di carica - batteria di riserva	☐	☐
☐	Controllo e pulizia del materiale sanitario	☐	☐
☐	Contributo in merito alla batteria in carica e gestione delle batterie	☐	☐
☐	Indicazioni - Segnalazioni	☐	☐

REGIONE
Lombardia

Checklist



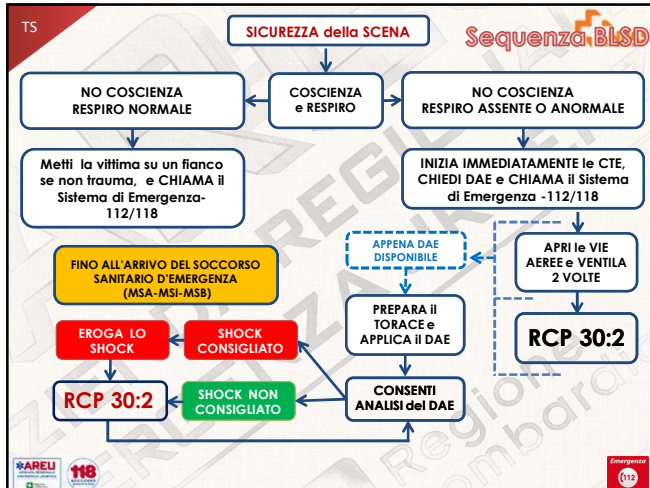
118

Emergenza
(112)

Caratteristiche del DAE

- Possibilità di registrazione ambientale
- Registrazione elettrocardiografica
- Possibilità di Code Summary
- Possibilità di interfaccia con PC per gestione dati, archivio e VRQ
- Possibilità di feed-back durante la RCP
- Possibilità di attenuare l'energia da erogare permettendo l'utilizzo di placche uguali per i pazienti adulti e i pediatrici

(in continua evoluzione...)



TS

e poi ...

Se la vittima:

- RIPRENDE UN RESPIRO NORMALE
- INIZIA A SVEGLIARSI
- APRE GLI OCCHI
- SI MUOVE

CHIAMA il Sistema di Emergenza Sanitaria 112/118 e SEGUI le INDICAZIONI

In caso di dubbio Continua RCP

Resta in contatto telefonico con il Sistema di Emergenza Sanitaria - 112/118

Logos: WAREL, 118, ANPAS, Emergenza 112

TS

se la vittima non si riprende:

Continua la RCP fino all'ARRIVO del soccorso sanitario extraospedaliero (MSA-MSI-MSB)

CONTATTA il Sistema di Emergenza Sanitaria-112/118 e ATTENDI INDICAZIONI

Logos: WAREL, 118, ANPAS, Emergenza 112

[illegible]

TS


CONCLUSIONI

NEL PAZIENTE IN ACC

INIZIA IMMEDIATAMENTE LE CTE

RIDUCI le INTERRUZIONI delle CTE

APPLICA il DAE APPENA DISPONIBILE

per migliorare la perfusione
coronarica e cerebrale ed aumentare
la percentuale di sopravvivenza

SENZA ESITI NEUROLOGICI










AREU
AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA



118
SOLLECCO
SANITARIO



Emergenza
112



ANPAS
LOMBARDIA



Regione
Lombardia

P-BLSD

**Rianimazione CardioPolmonare e
Defibrillazione Precoce**

IN ETA' PEDIATRICA



Struttura Formazione AREU

TS

ANPAS

RCP in età PEDIATRICA

SEGUE LA STESSA SEQUENZA
 DELL'ADULTO VITTIMA DI ACC

CON ALCUNE SPECIFICHE LEGATE
 PRINCIPALMENTE ALLA CONFORMAZIONE
 FISICA DEL BAMBINO

WAREL
 118
 Emergenza 112

TS

ANPAS

Compressioni Toraciche Esterne - CTE

POSIZIONE CORRETTA DELLE MANI

BAMBINO
 TECNICA AD UNA MANO
 (A DUE MANI SE NECESSARIO)

INFANTE
 TECNICA A DUE DITA

META' INFERIORE DELLO STERNO
 Comprimerne almeno 1/3 del diametro A/P del torace per profondità di
5 cm Bambino **4 cm Infante**

WAREL
 118
 Emergenza 112

TS

ANPAS

Apertura Delle Vie Aeree

Posizione neutra del capo nell'INFANTE
 (1 anno o fino a circa 10 Kg)

Estensione del capo e sollevamento del mento nel BAMBINO
 (da 1 a 8 anni o fino a 25 Kg)

WAREL
 118
 Emergenza 112

TS

Esegui 2 ventilazioni

- Insuffla un volume sufficiente per sollevare il torace
- DURATA: 1 secondo ognuna
- Lascia espirare
- Controlla l'efficacia (ESPANSIONE TORACICA)

EVITA di INSUFFLARE VOLUMI ECCESSIVI
Un volume eccessivo comporta :

- Riempimento di aria nello stomaco (con rischio di rigurgito, vomito e inalazione)
- Aumento della pressione intratoracica (con riduzione della perfusione cardiaca)

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

TS

Rianimazione Cardio-Polmonare - RCP

Rapporto CTE / Ventilazioni

15 : 2

SE NON SEI SOLO, Ogni 2 MINUTI (12/14 cicli)
CAMBIO OPERATORE CTE (CIRCA 2 MINUTI)
(DOPO 2 MINUTI, A CAUSA DELLO SFORZO FISICO, LE CTE PERDONO EFFICACIA)

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

TS

Utilizzo del DAE in età Pediatrica

SOTTO L'ANNO di ETÀ PER L'UTILIZZO DEL DAE
SEGUI LE INDICAZIONI del Sistema di Emergenza
Sanitaria 112/118

SE DISPONIBILI UTILIZZA GLI ATTENUATORI DI ENERGIA

L'UTILIZZO DELLE PLACCHE ADESIVE PEDIATRICHE È
INDICATO su BAMBINI fino a 8 ANNI di età
e con un PESO NON SUPERIORE ai 25 Kg.

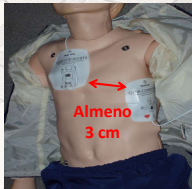
**È CONSENTITO L'UTILIZZO DELLE PLACCHE ADESIVE DA
ADULTI SOLO NEL CASO IN CUI NON SI DISPONGA DI
QUELLE PEDIATRICHE**

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

TS

Utilizzo del DAE in età Pediatrica

POSIZIONE DELLE PLACCHE ADESIVE



DESTRA:
sotto la clavicola destra,
a lato dello sterno

SINISTRA: centro della piastra
sulla linea ascellare media
all'altezza del 5° spazio
intercostale

RIDURRE AL MINIMO LE INTERRUZIONI DELLE CTE

ARELU

118

ANPAS

Emergenza 112

TS

Utilizzo del DAE in età Pediatrica

POSIZIONE DELLE PLACCHE ADESIVE



Se la distanza fra le due placche è inferiore ai 3 cm,
considera la posizione antero-posteriore
(una placca al centro del torace e l'altra sulle scapole)

ARELU

118

ANPAS

Emergenza 112

TS

Utilizzo del DAE in età Pediatrica

POSIZIONE DELLE PLACCHE ADESIVE



ARELU

118

ANPAS

Emergenza 112

TS

CONCLUSIONI



ALLERTA TEMPESTIVAMENTE IL SISTEMA DI EMERGENZA
SANITARIA-112/118

INIZIA IMMEDIATAMENTE LE COMPRESSIONI TORACICHE

RIDUCI AL MINIMO LE INTERRUZIONI DELLE
COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE

APPLICA IL DAE APPENA DISPONIBILE

SEGUI LA STESSA SEQUENZA Degli ADULTI ANCHE PER I
BAMBINI